EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	73633
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2023-11-06 13:41:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOVITA MARIA FUENTES ACUNA			RUN	: 5.700.503-3
F.Nac	: 14-12-2021	Edad	: 1 AÑO, 10 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-11-06	Fecha Egreso	: 2023-11-06 13:41:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- ACV isquémico subagudo territorio SUCA izquierda día 6-7
- Antecedentes: - FA en TACO acenocumarol control 24/10/23 INR 2.6 - ACV 2010, secuela mínima debilidad BC izquierda - Hipertensión arterial - Dislipidemia - Intolerancia a la glucosa

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
- FA en TACO acenocumarol control 24/10/23 INR 2.6
- ACV 2010, secuela mínima debilidad BC izquierda
- Hipertensión arterial
- Dislipidemia
- Intolerancia a la glucosa

Diestra mRS2
Consultó el 27/10/23 en SU de HSC por cuadro confusional, en ese entonces se describe sin otros síntomas neurológicos, se realizó TC de encéfalo sin contraste que resulta con lesiones secuelares occipital izquierdo y paramediano pontino derecho, sin lesiones agudas.
El 30/10/23 consulta en APS por cuadro de 1-2 días de evolución consistente en sensación vertiginosa de inició súbito en reposo asociado a nauseas y vómitos. Se maneja sintomáticamente en ese entonces, nota aumento de torpeza secuelar BC izquierda que por persistencia decide consultar en SU de HSC.
Consulta en SU de HSC el 04/11/23 en relación a cuadro vertiginoso y torpeza de HC izquierdo. Se registra en DAU FC 66 LPM, PA 160/100 mmg, T° 36.8°C, Sat 98% y HGT 106 mg/dL. Se describe al examen neurológico sin alteraciones, se realizó estudio complementario con laboratorio en que no se constatan alteraciones de relevancia y TC de encéfalo sin contraste en que comparado con estudio anterior, se evidencia hipodensidad cerebelosa anterior en hemisferio izquierdo de características isquémicas subagudas. Se complementó estudio con angioTC de cerebro y cuello en que no se evidencian estenosis significativas.
Se toma conocimiento del caso el 06/11/23 paciente con al menos 6 días de inicio de síntomas, en buenas condiciones generales, afebril, hemodinamia con tendencia a hipertensión leve, sin fluctuación neurológica, cefalea o alteración de nivel de conciencia.
Considerando estabilidad neurológica, y cursando día 6-7 del inicio del déficit, se considera eventual reinicio de anticoagulación con DOAC, se realizó TC de encéfalo de control en que se informa presencia de petequiado hemorrágico HI-1 por lo que se difiere reinicio de anticoagulación.
Se conversa con familiar responsable, se explican riesgos y beneficios, y se acuerda en conjunto continuar con hospitalización domiciliaria, control de TC de encéfalo sin contraste en 1 semana para definir reinicio de anticoagulación.

PLAN DE MANEJO:

Estudio: Realizo IPD
- Ecocardiograma ambulatorio.
- Control en 1 semana con TC de encéfalo sin contraste para evaluar reinicio de anticoagulación.

Tratamiento:
- Se difiere reinicio DOAC

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo 30 grados, movilizar asistida, pasar a sillón en forma diaria. Vigilancia permanente.
2. Régimen blando hiposódico asistido fraccionada a tolerancia.
3. Amlodipino 5 mg, 1/2 comp cada 12 horas
4. Atoirvastatina 20 mg, 1/2 comp al día
5. Carvedilol 6,25 mg, 1 comp cada 12 horas
6. Hidroclorotiazida 50 mg, 1 comp al día
7. Losartan 50 mg cada 12 horas
8. Metformina 850 mg 1 comp al día
9. Omeprazol 20 mg 1 al día
10. Kinesioterapia motora
11. Evaluación por fonoaudiología.
12. Control en 1 semana con TC de encéfalo sin contraste para evaluar reinicio de anticoagulación. Se difiere reinicio DOAC
13. Ecocardiograma ambulatorio.
14. Control en caso de necesidad en servicio de urgencias. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 06/11/23 TC de encéfalo sin contraste: respecto a control previo, se constata petequiado hemorrágico vermiano.
- 05/11/23 AngioTC de cerebro y cuello: ateromatosis sin estenosis significativa.
- 05/11/23 ColT 146, HDL 54, LDL 76, TGL 81. TSH 2.91. T4L 1.38. HbA1c 5.7
- 04/11/23 TC de encéfalo sin contraste: lesiones secuelares occipital izquierdo y paramediano pontino derecho, hipodensidad cerebelosa superior en hemisferio izquierdo
- 04/11/23 Glic 103, Creat 0.7, Uremia 41, BUN 19, ELP 134/4.3/102, Hb 13, Hto 39.2, Leuco 6700, Plaq 177.000, PCR 7.6. P Hepático normal. INR 3.78. TTPa 37. LDH 263. Tropo , ColT 153, TGL 83. OC Leuco 0.2, bact escaso
- 27/10/23 INR 2.16, Tropo 10.9
- 27/10/23 TC de encéfalo sin contraste: lesiones secuelares occipital izquierdo y paramediano pontino derecho, sin lesiones agudas.

OBSERVACIONES:

Ex neurológico al alta:
- Mental: Vigil, orientada en tiempo y espacio, atenta, sin alteración del lenguaje, sin disartria.
- PC: pupilas isocoricas, RFM +/+, CV conservado, OCM normal sin nistagmus, sensibilidad facial simétrica, leve PFC izquierda. Protruye lengua en linea media, paladar blando simétrico.
- Motor: PMP negativa, al testing logra M5 en forma simétrica, ROT normales, plantar extensor izquierdo
- Sensitivo: sin déficit
- Cerebelo: dismetría y disdiadococinesia BC izquierda
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO